内科含诊断系统性红斑狼疮 ★★★（0~2题）

自身抗体

- 抗核抗体谱（2007）
  - dsDNA（标记）：确诊和判断活动性最佳，狼疮肾
  - ANA：筛查
  - ENA “血沉 ESR”（2016）
    - 与活动性无关“ASSS”
    - Sm（标记）：早期或不典型者诊断（特异性最高“绑起来最特别”）
    - SSA：继发干燥综合征、平滑肌受累、光过敏、皮损、白细胞↓、血管炎、新生儿狼疮“平滑干光白眼狼”（2009）
    - SSB：继发干燥综合征
    - RNP：雷诺现象、肺动脉高压“混混人品被高空雷击”
    - rRNP：神经精神狼疮（2014）
- 抗磷脂抗体 “没狼心瓜皮哎、血栓流产”
  - 抗心磷脂抗体、狼疮抗凝物（梅毒血清试验假阳性）、抗 β_2 糖蛋白抗体 /β_2-GPI（2007、2025）
  - 血管血栓形成（可发生在所有血管）、习惯性自发性流产、血小板↓（2011、2022、2023）
- 抗组织细胞抗体
  - 抗红细胞抗体（Coombs 试验，2010）、抗血小板抗体、抗神经元抗体
  - 活动期可伴一系或全血细胞↓、网织红↑
- 可有 RF、ANCA

青年女性多见 + 发热 + 多系统损害（2013、2024）

诊断标准 “咏狼 脸上长斑口腔烂 浆膜关节会发炎 脱发脱血有癫痫 主要死因肾病变 ANA 筛阳性补 ds sm 磷脂 b”（2007、2018、2022）

①皮肤狼疮：皮疹（鼻梁和双颧颊部蝶形红斑、盘状红斑等）
②口腔或鼻咽部溃疡（一般不痛）
③浆膜炎
④滑膜炎：非侵蚀性关节炎
⑤脱发
⑥一系或全血细胞↓
⑦ NPLE：癫痫、精神异常等
⑧肾：蛋白尿或红细胞管型
⑨ ANA、抗 dsDNA、抗 Sm、抗磷脂抗体、低补体、Coombs 试验

治疗（2024）

- 糖皮质激素 + 环磷酰胺或吗替麦考酚酯
  （急性危重型如严重急进性肾炎、中枢神经损害、溶血性贫血、血小板减少性紫癜用大剂量甲泼尼龙冲击疗法）
- 羟氯喹：背景 / 基础治疗“羟基”